

# Welcher Herztest bei welchem Verdacht?

Die ESC-Leitlinie zum chronischen Koronarsyndrom ordnet die Bildgebung nach der klinischen Vortestwahrscheinlichkeit. In sechs Schritten.

Weiterwischen >

# Anatomie oder Funktion?

---

- Die CT-Koronarangiographie zeigt das Gefäß: Stenose, Plaque, Verlauf
- Die Myokardszintigraphie zeigt den Muskel: Durchblutung unter Belastung und in Ruhe
- Beide beantworten verschiedene Fragen und ersetzen einander nicht

## STUFE 1

# Niedrige bis moderate Wahrscheinlichkeit

---

- Klinische Vortestwahrscheinlichkeit über 5 bis 50 Prozent
- CT-Koronarangiographie empfohlen, um eine obstruktive KHK auszuschließen (Klasse I, Evidenzgrad A)
- Nicht geeignet bei ausgeprägter Verkalkung, Arrhythmie oder eGFR unter 30 ml/min

# über 50 %

Ab hoher klinischer Vortestwahrscheinlichkeit ist die funktionelle Bildgebung der empfohlene Erstlinientest (ESC 2024, Klasse I).

## STUFE 2

# Was die Szintigraphie beantwortet

---

- Welches Areal unter Belastung minderperfundiert ist
- Ob der Defekt reversibel ist (Ischämie) oder fixiert
- Fixiert heißt meist Narbe, seltener vitales Gewebe oder ein Artefakt. Das EKG-Gating hilft bei der Abgrenzung

# HR 0,93

ISCHEMIA, 5.179 Patienten: die initial invasive Strategie senkte den kombinierten kardiovaskulären Endpunkt nicht (95 %-KI 0,80 bis 1,08).

---

# Vor der Überweisung anrufen

Wir klären mit Ihnen, welche Modalität Ihre Fragestellung beantwortet, und sparen Ihrem Patienten den Weg über den falschen Test. Belastungs- und Ruheaufnahmen am selben Tag.

**Nuklearmedizin im RNZ Nürnberg**  
**ESC CCS 2024 · NEJM 2020, PMID 32227755**  
**[www.rnz-radiologie.de](http://www.rnz-radiologie.de)**